

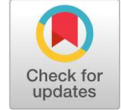


ISSN: 1859-1779

Nghiên cứu Y học

Tạp chí Y học Thành phố Hồ Chí Minh;27(3):16-25

<https://doi.org/10.32895/hcjm.m.2024.03.03>



Ý nghĩ tự tử và các hành vi nguy hại sức khỏe ở học sinh trung học phổ thông tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2024

Nguyễn Thị Trang¹, Lê Võ Hồng Tuyết¹, Mai Lê Xuân¹, Trần Thị Hoài Thương¹,
Thái Thanh Trúc^{1,*}

¹Khoa Y tế công cộng, Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tóm tắt

Đặt vấn đề: Tự tử là một quá trình phức tạp, thường được bắt đầu bằng ý nghĩ tự tử và phát triển theo thời gian thành kế hoạch và cố gắng tự tử dẫn đến thương tích hoặc tử vong. Nghiên cứu này mô tả mức độ phổ biến của ý nghĩ tự tử cũng như các loại hành vi nguy hại sức khỏe và đánh giá mối liên hệ giữa các hành vi với ý nghĩ tự tử ở học sinh trung học phổ thông (THPT) tại Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) năm 2024.

Đối tượng - Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu cắt ngang được triển khai tại 4 trường THPT tại TP.HCM với sự tham gia của 1508 học sinh. Học sinh trả lời bộ câu hỏi tự điền bao gồm các câu hỏi về đặc điểm dân số xã hội, trải nghiệm bất lợi, sức khỏe tâm thần, các hành vi nguy hại sức khỏe.

Kết quả: Tỷ lệ học sinh có ý nghĩ tự tử khá cao với 22,3%. Học sinh nữ, có áp lực học tập, đồng tính/lưỡng tính, không sống cùng cha mẹ, cha mẹ không sống chung, cảm nhận có quan hệ không tốt với thầy cô hoặc bạn bè thì có tỷ lệ có ý nghĩ tự tử cao hơn. Ngoài ra, tỷ lệ học sinh có ý nghĩ tự tử cao khi có các trải nghiệm bất lợi và có các vấn đề sức khỏe tâm thần. Khi học sinh thực hiện các hành vi nguy hại sức khỏe thì khả năng hình thành ý nghĩ tự tử cao hơn từ 1,44 đến 2,04 lần. Bên cạnh đó, học sinh THPT có xu hướng đa hành vi nguy hại sức khỏe và tỷ lệ ý nghĩ tự tử cao ở những học sinh có đồng thời nhiều hành vi, cụ thể học sinh có 2 hành vi (OR=1,84; KTC 95% 1,23-2,76), và 3 hành vi trở lên (OR=2,91; KTC 95% 1,90-4,48) thì tỷ lệ này cao hơn so với học sinh không có hoặc chỉ có 1 hành vi.

Kết luận: Các hành vi nguy hại sức khỏe và các yếu tố cá nhân, gia đình, môi trường học tập, các trải nghiệm bất lợi và sức khỏe tâm thần kém có mối liên quan có ý nghĩa thống kê với ý nghĩ tự tử. Nhận diện học sinh THPT có các hành vi và các yếu tố nguy cơ hình thành ý nghĩ tự tử là rất quan trọng cho các chiến lược phòng ngừa tự tử.

Từ khóa: ý nghĩ tự tử; hành vi nguy hại sức khỏe; học sinh trung học phổ thông.

Ngày nhận bài: 20-06-2024 / Ngày chấp nhận đăng bài: 24-07-2024 / Ngày đăng bài: 26-07-2024

*Tác giả liên hệ: Thái Thanh Trúc. Khoa Y tế công cộng, Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
E-mail: thaithanhtruc@ump.edu.vn

© 2024 Bản quyền thuộc về Tạp chí Y học Thành phố Hồ Chí Minh.

Abstract

SUICIDAL IDEATION AND HEALTH-RISK BEHAVIORS IN HIGH SCHOOL STUDENTS IN HO CHI MINH CITY IN 2024

Nguyen Thi Trang, Le Vo Hong Tuyet, Mai Le Xuan, Tran Thi Hoai Thuong, Thai Thanh Truc

Objectives: Suicide forms by a complex process, often initiate from suicidal ideation, progress over time into planning and making suicide attempts, which lead to injury or death. This study describes the prevalence of suicidal ideation as well as various health-risk behaviors and assesses the relationship between these behaviors and suicidal ideation among high school students in Ho Chi Minh City in 2024.

Methods: A cross-sectional study was conducted on 1.508 students from 4 high schools in Ho Chi Minh City. Students responded to a self-administered questionnaire on suicidal ideation including information about socio-demographic characteristics, adverse experiences, mental health and health-risk behaviors.

Results: The prevalence of students with suicidal ideation was relatively high at 22.3%. Female students, those under academic pressure, non-heterosexual students, those not living with parents, students with bad relationships with teachers, and those with friends were more likely to have suicidal ideation. The likelihood of having suicidal ideation increased with adverse experiences and mental health issues. Presence of health-risk behaviors featured the odds of having suicidal ideation at 1.44 to 2.04 times. Furthermore, regarding multiple health-risk behaviors, the odds of having suicidal ideation significantly increased among students presenting two behaviors (OR=1.84; 95% CI 1.23-2.76) and three or more behaviors (OR=2.91; 95% CI 1.90-4.48), compared to those with none or only one behavior.

Conclusion: Our study explored multiple health-risk behaviors, individual, family, and school environment factors, along with adverse experiences and poor mental health, that are significantly associated with suicidal ideation. Identifying high school students with such behaviors and risk factors for suicidal ideation is crucial for the development of suicide prevention strategies.

Keywords: suicidal ideation; health-risk behaviors; high school students.

1. ĐẶT VẤN ĐỀ

Tự tử là vấn đề nghiêm trọng toàn cầu. Ước tính có khoảng 700.000 trường hợp tự tử vong do tự tử mỗi năm trên toàn thế giới và hơn 77,0% số vụ tự tử xảy ra ở các nước có thu nhập thấp và trung bình, trong đó có Việt Nam [1]. Đây được xem là nguyên nhân gây tử vong đứng hàng thứ 2 ở trẻ em và vị thành niên [2]. Ý nghĩ tự tử là một trong những yếu tố nguy cơ dự báo cho hành vi tự tử và ý nghĩ này được báo cáo tăng nhanh trong độ tuổi từ 12 đến 17 [3]. Ngoài ra do những thay đổi lớn về tâm lý, thể chất mà ở tuổi vị thành niên cũng chính là giai đoạn đánh dấu sự xuất hiện và gia tăng đồng thời của nhiều hành vi nguy hại sức khỏe [4]. Sự gia tăng thực hiện các hành vi rủi ro và mạo hiểm ở vị thành niên góp phần làm giảm dần nỗi sợ chết khiến nguy cơ hình thành ý nghĩ tự tử tăng cao [5].

Mỗi một vụ tự tử là một bi kịch cho gia đình, cộng đồng và xã hội. Việc đánh giá rủi ro tiềm ẩn hình thành ý nghĩ tự tử là điều vô cùng khó khăn bởi tính chất phức tạp của nó. Tuy nhiên, một số yếu tố nguy cơ phổ biến vẫn tồn tại đến ngày nay bao gồm mắc các rối loạn tâm thần, nạn nhân của bạo lực, sống trong gia đình không hạnh phúc, các hành vi lối sống không lành mạnh. Mặc dù có rất nhiều yếu tố nguy cơ từ cấp độ cá nhân, gia đình, cộng đồng, môi trường sống dẫn đến hành vi tự tử, nhưng hầu hết các yếu tố này đều có thể phòng tránh được. Do đó, việc nhận biết các yếu tố rủi ro này là đặc biệt quan trọng trong các chiến lược phòng ngừa tự tử ở vị thành niên.

Chính vì vậy, nghiên cứu này có mục tiêu xác định mức độ phổ biến của ý nghĩ tự tử cũng như các loại hành vi nguy hại sức khỏe và đánh giá mối liên hệ giữa các hành vi với ý nghĩ tự tử ở học sinh trung học phổ thông (THPT) tại Thành

phố Hồ Chí Minh (TP.HCM). Từ kết quả của nghiên cứu có thể giúp nhận diện học sinh có các hành vi và các yếu tố nguy cơ góp phần hình thành ý nghĩ tự tử từ đây có thể xây dựng các chương trình ngăn ngừa tự tử tập trung vào các đối tượng cụ thể nhằm đạt hiệu quả tối ưu.

2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Đối tượng nghiên cứu

Có 1508 học sinh THPT được mời tham gia nghiên cứu. Nghiên cứu được tiến hành từ tháng 02/2024 đến tháng 04/2024 tại TP.HCM.

2.1.1. Tiêu chuẩn chọn mẫu

Học sinh được sự chấp thuận cho tham gia nghiên cứu của phụ huynh/người giám hộ và đồng ý tham gia nghiên cứu ký tên vào phiếu chấp thuận tham gia nghiên cứu sau khi được nghiên cứu viên giải đáp các thông tin về nghiên cứu.

2.2. Phương pháp nghiên cứu

2.2.1. Thiết kế nghiên cứu

Nghiên cứu cắt ngang.

2.2.2. Cỡ mẫu

Cỡ mẫu được xác định dựa trên công thức ước lượng một tỷ lệ với tỷ lệ ước tính là 50,2%, sai số ước tính là 5,0% và dự trù sự từ chối tham gia là 30,0%. Việc dự trù tỷ lệ từ chối tham gia cao là do nghiên cứu phải lấy đồng thuận của phụ huynh/người giám hộ và của học sinh. Vì vậy cỡ mẫu tối thiểu cho nghiên cứu là 1100 học sinh.

2.2.3. Phương pháp thu thập số liệu

Chúng tôi chọn ngẫu nhiên 2 quận và 2 huyện trong tổng số 22 quận/huyện và thành phố tại Thành phố Hồ Chí Minh. Kết quả chọn được quận Tân Phú, quận 12, huyện Bình Chánh và huyện Hóc Môn. Sau đó, dựa vào danh sách các trường THPT tại mỗi quận/huyện được chọn, chúng tôi chọn ngẫu nhiên 1 trường THPT đưa vào nghiên cứu. Kết quả thu được là 4 trường THPT công lập không chuyên. Tại mỗi trường, chọn ngẫu nhiên mỗi khối 3 lớp (3 lớp 10, 3 lớp 11, 3 lớp 12) và vì vậy trong nghiên cứu này có tổng cộng 36 lớp tham gia. Trong tổng số 1508 học sinh được mời tham gia

nghiên cứu có 1374 học sinh đủ điều kiện đưa vào phân tích kết quả sau khi kiểm tra, làm sạch số liệu.

Học sinh trả lời bộ câu hỏi tự điền ngay tại lớp học trong khoảng thời gian 30-45 phút. Bộ câu hỏi bao gồm các câu về đặc điểm cá nhân, gia đình, môi trường học tập, các trải nghiệm bất lợi, các vấn đề sức khỏe tâm thần, các hành vi nguy hại sức khỏe và ý nghĩ tự tử.

Hầu hết các thang đo dùng trong nghiên cứu đã được đánh giá thuộc tính và chuẩn hóa. Ý nghĩ tự tử và các hành vi nguy hại sức khỏe được đánh giá dựa trên thang đo Youth Risk Behavior Survey (YRBS) được phát triển bởi Trung tâm phòng chống dịch bệnh Hoa Kỳ và được sử dụng rộng rãi tại các quốc gia [6]. Thang đo sức khỏe tâm thần Depression Anxiety Stress scale 21 (DASS-21) đo lường tình trạng trầm cảm, lo âu, căng thẳng gồm 21 câu hỏi, tương ứng 7 câu cho mỗi phần, đã được chuẩn hóa tại Việt Nam [7].

Dựa trên thang đo YRBS, ý nghĩ tự tử được đo lường khi học sinh trả lời có hoặc không có ý nghĩ tự tử trong 12 tháng trước khảo sát(8). Các hành vi nguy hại sức khỏe bao gồm hút thuốc lá, uống rượu bia trên mức khuyến cáo, đánh nhau, lái xe không an toàn, hoạt động thể chất không đủ, thời gian ngủ không đủ. Hành vi hút thuốc lá và uống rượu bia trên mức khuyến cáo được xác định bằng số ngày thực hiện trong 30 ngày qua(8). Đánh nhau được đo lường bằng số lần học sinh thực hiện hành vi này trong 12 tháng trước (8). Lái xe không an toàn được đánh giá khi học sinh lái xe sau khi đã uống rượu bia hoặc sử dụng điện thoại khi đang lái xe. Hoạt động thể chất không đủ được ghi nhận nếu học sinh có tổng thời gian vận động ít nhất 60 phút/ngày ít hơn 5 ngày/tuần. Thời gian ngủ không đủ nếu học sinh trả lời ngủ ít hơn 8 tiếng mỗi đêm (8). Tất cả các hành vi được phân nhóm thành dạng nhị giá (có/không), trong đó đối với hành vi hút thuốc lá và uống rượu bia trên mức khuyến cáo, giá trị ‘không’ bao gồm học sinh chưa bao giờ thực hiện hoặc hiện tại không có hành vi tương ứng và lái xe không an toàn giá trị ‘không’ bao gồm học sinh không lái xe hoặc lái xe an toàn.

2.2.4. Xử lý và phân tích số liệu

Dữ liệu được tổng hợp và phân tích bằng phần mềm Stata 17.0. Kiểm định Chi bình phương hoặc Fisher được dùng nhằm xét mối liên quan giữa các yếu tố, các hành vi đến ý nghĩ tự tử và tỷ số chênh cùng khoảng tin cậy 95% cũng được báo cáo.

3. KẾT QUẢ

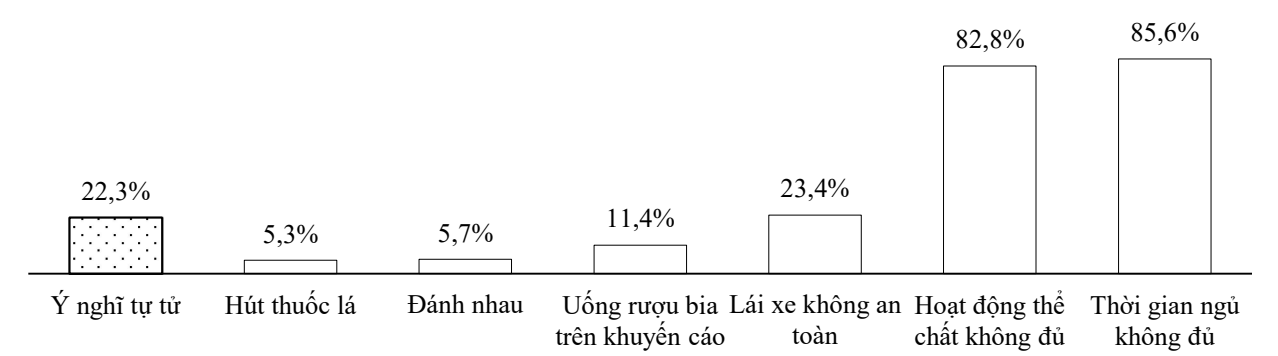
Trong tổng số 1374 học sinh THPT độ tuổi từ 15 đến 19 đưa vào phân tích, học sinh nữ chiếm nhiều hơn nam (56,3% so với 43,7%), học sinh 3 khối 10, 11 và 12 trong nghiên cứu tương đương nhau. Hơn 60,0% học sinh có áp lực học tập và 16,7% nhận thức mình không thuộc nhóm dị tính. Phần lớn

học sinh đang sống chung với cả cha mẹ (86,0%) và có mối quan hệ bình thường hoặc tốt với thầy cô, bạn bè (Bảng 1).

Hơn một nửa học sinh trong nghiên cứu đã từng chứng kiến bạo lực thể chất và hầu hết học sinh không có các trải nghiệm bất lợi. Tỷ lệ học sinh có các vấn đề sức khỏe tâm thần được báo cáo ở mức khá cao với các con số dao động từ 43,4% đến gần 64,0% (Bảng 1).

Bảng 1. Đặc điểm dân số xã hội của học sinh (n=1374)

Đặc điểm		Tần số (n)	Tỷ lệ (%)	Đặc điểm		Tần số (n)	Tỷ lệ (%)
Giới tính	Nam	600	43,7	Chứng kiến bạo lực thể chất	Có	693	50,4
	Nữ	774	56,3		Không	681	49,6
Khối lớp	10	474	34,5	Bị bắt nạt	Có	200	14,6
	11	455	33,1		Không	1174	85,4
	12	445	32,4	Bị lạm dụng tình dục	Có	54	3,9
Áp lực học tập	Có	871	63,4		Không	1320	96,1
	Không	503	36,6	Bị bạo lực hèn hỏ	Có	37	2,7
Xu hướng tính dục	Dị tính	1145	83,3		Không	1337	97,3
	Đồng tính/ Lưỡng tính/ Khác	229	16,7	Cảm giác buồn bã liên tục ≥ 2 tuần	Có	596	43,4
Người sống cùng	Cha và mẹ	1181	86,0		Không	778	56,6
	Cha hoặc mẹ	146	10,6	Căng thẳng	Có	617	44,9
	Khác	47	3,4		Không	757	55,1
Hôn nhân cha mẹ	Sống chung	1181	86,0	Lo âu	Có	875	63,7
	Ly hôn/Ly thân	193	14,0		Không	499	36,3
Mối quan hệ với thầy cô	Không tốt	38	2,8	Trầm cảm	Có	803	58,4
	Bình thường	1071	78,0		Không	571	41,6
	Tốt	265	19,2				
Mối quan hệ với bạn bè	Không tốt	28	2,0				
	Bình thường	704	51,3				
	Tốt	642	46,7				



Hình 1. Tỷ lệ ý nghĩ tự tử và các hành vi nguy hại sức khỏe ở học sinh (n=1374)

Kết quả Hình 1 cho thấy tỷ lệ học sinh có ý nghĩ tự tử trong 12 tháng trước khảo sát là 22,3%. Tỷ lệ các hành vi nguy hại sức khỏe ở mức khá cao với 5,3% hút thuốc lá, 5,7% đánh nhau, 11,4% uống rượu bia trên mức khuyến cáo, 23,4% lái xe không an toàn, 82,8% hoạt động thể chất không đủ, 85,6% có thời gian ngủ không đủ.

Về mối liên quan, ý nghĩ tự tử có liên quan đến giới tính (nam thấp hơn nữ với $OR=0,44$; KTC 95% 0,33-0,57), áp lực học tập (nhóm có áp lực học tập cao hơn nhóm không có áp lực với $OR=3,00$; KTC 95% 2,20-4,08), xu hướng tính dục (ở nhóm nhận thức mình là đồng tính, lưỡng tính cao hơn nhóm dị tính với $OR=2,70$; KTC 95% 1,99-3,66). Ngoài ra, người sống cùng, hôn nhân cha mẹ, các mối quan hệ cũng được báo cáo có ảnh hưởng đến ý nghĩ tự tử. Cụ thể, học sinh không sống cùng với cha mẹ có ý nghĩ tự tử cao hơn các học sinh sống cùng ($OR=2,84$; KTC 95% 1,57-5,16) và nhóm có cha mẹ sống chung với nhau cũng như có mối quan hệ tốt với thầy cô hoặc bạn bè có tỷ lệ ý nghĩ tự tử thấp hơn với OR

lần lượt là 0,57 (KTC 95% 0,41-0,79), 0,32 (KTC 95% 0,15-0,67), 0,24 (KTC 95% 0,11-0,52) (Bảng 2).

Tất cả các trải nghiệm bất lợi của học sinh đều có mối liên quan có ý nghĩa thống kê với ý nghĩ tự tử. Học sinh chứng kiến bạo lực thể chất, bị bắt nạt, bị lạm dụng tình dục, bị bạo lực hèn hơ cao hơn nhóm không trải qua các sự kiện trên với OR lần lượt là 1,67 (KTC 95% 1,29-2,16), 3,70 (KTC 95% 2,70-5,07), 1,95 (KTC 95% 1,10-3,45) và 2,17 (KTC 95% 1,10-4,27). Bên cạnh đó, kết quả nghiên cứu ghi nhận các vấn đề sức khỏe tâm thần có ảnh hưởng quan trọng đến ý nghĩ tự tử ở học sinh. Cụ thể, những học sinh đang có các vấn đề về sức khỏe tâm thần thì tỷ lệ có ý nghĩ tự tử cao hơn nhóm không có vấn đề tương ứng với OR dao động trong khoảng từ 5,48 đến 10,73, trong đó khi học sinh có cảm giác buồn bã, tuyệt vọng liên tục trong 2 tuần trở lên cho thấy mức ước lượng liên quan đến ý nghĩ tự tử cao nhất ($OR=10,73$; KTC 95% 7,74-14,88) (Bảng 2).

Bảng 2. Mối liên quan giữa ý nghĩ tự tử và đặc điểm dân số xã hội của học sinh (n=1374)

Đặc điểm	Ý nghĩ tự tử		OR (KTC 95%)	p
	Có, n (%)	Không, n (%)		
Đặc điểm cá nhân				
Giới tính				
Nam	88 (14,7)	512 (85,3)	0,44 (0,33-0,57)	<0,001
Nữ	219 (28,3)	555 (71,7)	1	
Khối lớp				
10	108 (22,8)	366 (77,2)	1	
11	95 (20,9)	360 (79,1)	0,89 (0,65-1,22)	0,482
12	104 (23,4)	341 (76,6)	1,03 (0,76-1,41)	0,833
Áp lực học tập				
Có	248 (28,5)	623 (71,5)	3,00 (2,20-4,08)	<0,001
Không	59 (11,7)	444 (88,3)	1	
Xu hướng tính dục				
Dị tính	218 (19,0)	927 (81,0)	1	
Đồng tính/Lưỡng tính/Khác	89 (38,9)	140 (61,1)	2,70 (1,99-3,66)	<0,001
Đặc điểm gia đình				
Người sống cùng				
Cha và mẹ	244 (20,7)	937 (79,3)	1	
Cha hoặc mẹ	43 (29,5)	103 (70,5)	1,60 (1,09-2,35)	0,016
Khác	20 (42,6)	27 (57,4)	2,84 (1,57-5,16)	0,001

Đặc điểm	Ý nghĩ tự tử		OR (KTC 95%)	p
	Có, n (%)	Không, n (%)		
Hôn nhân cha mẹ				
Sống chung	246 (20,8)	935 (79,2)	0,57 (0,41-0,79)	0,001
Ly hôn/Ly thân	61 (31,6)	132 (68,4)	1	
Môi trường học tập				
Mối quan hệ với thầy cô				
Không tốt	14 (36,8)	24 (63,2)	1	
Bình thường	251 (23,4)	820 (76,6)	0,52 (0,27-1,03)	0,061
Tốt	42 (15,8)	223 (84,2)	0,32 (0,15-0,67)	0,003
Mối quan hệ với bạn bè				
Không tốt	14 (50,0)	14 (50,0)	1	
Bình thường	169 (24,0)	535 (76,0)	0,32 (0,15-0,68)	0,003
Tốt	124 (19,3)	518 (80,7)	0,24 (0,11-0,52)	<0,001
Trải nghiệm bất lợi				
Chứng kiến bạo lực thể chất				
Có	185 (26,7)	508 (73,3)	1,67 (1,29-2,16)	<0,001
Không	122 (17,9)	559 (82,1)	1	
Bị bắt nạt				
Có	91 (45,5)	109 (54,5)	3,70 (2,70-5,07)	<0,001
Không	216 (18,4)	958 (81,6)	1	
Bị lạm dụng tình dục				
Có	19 (35,2)	35 (64,8)	1,95 (1,10-3,45)	0,023
Không	288 (21,8)	1032 (78,2)	1	
Bị bạo lực hèn hò				
Có	14 (37,8)	23 (62,2)	2,17 (1,10-4,27)	0,025
Không	293 (21,9)	1044 (78,1)	1	
Sức khỏe tâm thần				
Cảm giác buồn bã liên tục ≥2 tuần				
Có	256 (43,0)	340 (57,0)	10,73 (7,74-14,88)	<0,001
Không	51 (6,6)	727 (93,4)	1	
Căng thẳng				
Có	232 (37,6)	385 (62,4)	5,48 (4,11-7,31)	<0,001
Không	75 (9,9)	682 (90,1)	1	
Lo âu				
Có	270 (30,9)	605 (69,1)	5,57 (3,87-8,02)	<0,001
Không	37 (7,4)	462 (92,6)	1	
Trầm cảm				
Có	261 (32,5)	542 (67,5)	5,50 (3,93-7,69)	<0,001
Không	46 (8,1)	525 (91,9)	1	

Bảng 3. Mối liên quan giữa ý nghĩ tự tử và hành vi nguy hại sức khỏe của học sinh (n=1374)

Đặc điểm	Ý nghĩ tự tử		OR (KTC 95%)	p
	Có, n (%)	Không, n (%)		
Hút thuốc lá				
Có	17 (23,3)	56 (76,7)	1,06 (0,61-1,85)	0,842
Không	290 (22,3)	1011 (77,7)	1	
Uống rượu bia trên mức khuyến cáo				
Có	51 (32,7)	105 (67,3)	1,83 (1,27-2,62)	0,001
Không	256 (21,0)	962 (79,0)	1	
Đánh nhau				
Có	28 (35,9)	50 (64,1)	2,04 (1,26-3,30)	0,004
Không	279 (21,5)	1017 (78,5)	1	
Lái xe không an toàn				
Có	88 (27,4)	233 (72,6)	1,44 (1,08-1,92)	0,013
Không	219 (20,8)	834 (79,2)	1	
Hoạt động thể chất không đủ				
Có	270 (23,8)	867 (76,2)	1,68 (1,16-2,45)	0,007
Không	37 (15,6)	200 (84,4)		
Thời gian ngủ không đủ				
Có	276 (23,5)	900 (76,5)	1,65 (1,10-2,48)	0,015
Không	31 (15,7)	167 (84,3)	1	
Số lượng hành vi nguy hại sức khỏe				
0 – 1	33 (13,0)	220 (87,0)	1	
2	166 (21,7)	600 (78,3)	1,84 (1,23-2,76)	0,003
≥3	108 (30,4)	247 (69,6)	2,91 (1,90-4,48)	<0,001

Khi xét mối tương quan giữa các hành vi nguy hại sức khỏe với ý nghĩ tự tử thì ngoại trừ hành vi hút thuốc lá, tất cả các hành vi nguy hại khảo sát trong nghiên cứu đều cho thấy mối liên quan có ý nghĩa thống kê với ý nghĩ tự tử. Theo đó, khi học sinh uống rượu bia trên mức khuyến cáo (OR=1,83; KTC 95% 1,27-2,62), đánh nhau (OR=2,04; KTC 95% 1,26-3,30), lái xe không an toàn (OR=1,44; KTC 95% 1,08-1,92); hoạt động thể chất không đủ (OR=1,68; KTC 95% 1,16-2,45), thời gian ngủ không đủ (OR=1,65; KTC 95% 1,10-2,48) thì sẽ có khả năng có ý nghĩ tự tử cao hơn so với học sinh không thực hiện các hành vi tương ứng (Bảng 3).

Bên cạnh đó, học sinh THPT tại TP.HCM có xu hướng đa hành vi nguy hại sức khỏe và số lượng hành vi có mối tương quan thuận với ý nghĩ tự tử. Tỷ lệ ý nghĩ tự tử cao hơn trong nhóm học sinh có đồng thời 2 hành vi (OR=1,84; KTC 95% 1,23-2,76) và 3 hành vi trở lên (OR=2,91; KTC 95% 1,90-

4,48) (Bảng 3).

4. BÀN LUẬN

Tự tử là một vấn đề sức khỏe cộng đồng quan trọng và thực tế rằng đã có rất nhiều nghiên cứu được thực hiện với mục đích xác định nguyên nhân dẫn đến hành vi này nhằm thiết lập các chiến lược ngăn ngừa giúp giảm tỷ lệ tự tử và cung cấp các dịch vụ cải thiện sức khỏe hiệu quả. Cho đến nay, các yếu tố nguy cơ chính liên quan đến ý nghĩ tự tử dần được biết đến nhiều hơn như trầm cảm, các trải nghiệm bất lợi và các đặc điểm dân số xã hội. Tuy nhiên, vẫn còn một khía cạnh khác ít được chú ý đó là sự gia tăng các hành vi nguy hại sức khỏe ở vị thành niên những năm gần đây cũng được báo cáo là có tác động đến ý nghĩ tự tử. Trong nghiên cứu này, tỷ lệ học sinh THPT tại TP.HCM có ý nghĩ tự tử là

22,3% cao hơn nhiều so với nghiên cứu thực hiện tại Hà Nội (14,2%), Tây Ninh (13,0%) và gần tương đồng với các nghiên cứu trên thế giới [9-13].

Sự khác biệt về tỷ lệ ý nghĩ tự tử có thể được giải thích qua các lý do sau:

Đầu tiên, bằng chứng từ các quốc gia trên thế giới đã chỉ ra rằng xu hướng tính dục có ảnh hưởng đến ý nghĩ tự tử, cụ thể thanh thiếu niên đồng tính, lưỡng tính hoặc mô tả giới tính theo cách khác có ý nghĩ và hành vi tự tử cao hơn nhóm dị tính gấp 6 đến 17 lần [9,11]. Ở nghiên cứu của chúng tôi, tỷ lệ học sinh báo cáo mình không thuộc nhóm dị tính cao hơn 1,45 lần so với dữ liệu ở Hà Nội nhưng tỷ lệ này lại thấp hơn nghiên cứu tại Iceland [9,11].

Thứ hai, phần lớn các nghiên cứu trước đây đều nhất quán rằng sức khỏe tâm thần kém là yếu tố góp phần thúc đẩy hình thành ý nghĩ tự tử ở trẻ vị thành niên [9,10,12]. Tại TP.HCM học sinh THPT hiện đang có các vấn đề trầm cảm, lo âu cao hơn rất nhiều so với học sinh tại Tây Ninh, với tỷ lệ được báo cáo dao động từ 58,0% đến 63,0%. Kết quả này gần tương đồng với các báo cáo trên thế giới trong khi ở Tây Ninh số liệu này chỉ từ 12,0% đến 20,0% [10,12].

Thứ ba, một số hành vi lối sống không lành mạnh có thể làm tăng nguy cơ hiện diện ý nghĩ tự tử ở học sinh trung học. Kết luận này hằng định trong các nghiên cứu dịch tễ học ở các quốc gia khác nhau [12,14,15]. Điều này góp phần lý giải cho tỷ lệ ý nghĩ tự tử khá cao ở học sinh THPT tại TP.HCM bởi có đến hơn 97,0% học sinh nơi đây đang thực hiện các hành vi gây tổn hại đến sức khỏe, con số này cao hơn tỷ lệ được báo cáo tại Hà Nội (73,5%) [15].

Thứ tư, sự chênh lệch này cũng có thể đến từ sự khác biệt vùng miền và văn hóa [16].

Cuối cùng, nghiên cứu của chúng tôi thực hiện lấy mẫu vào thời điểm học sinh bước vào kỳ thi nên khó tránh khỏi những căng thẳng tâm lý đến từ điểm số, thành tích, áp lực cha mẹ nên có khả năng có ý nghĩ tự tử ở học sinh. Từ kết quả nghiên cứu của chúng tôi có thể thấy rằng ý nghĩ tự tử ở học sinh THPT tại Việt Nam đang có xu hướng gia tăng đáng kể theo thời gian và cần ngay các chương trình, chiến lược bảo vệ nhóm dân số này trước khi xảy ra các hậu quả nghiêm trọng khác.

Về các yếu tố nguy cơ, nghiên cứu của chúng tôi cho kết quả tương tự với dữ liệu từ các quốc gia trên toàn cầu, trong

đó chứng minh mối liên quan mật thiết giữa ý nghĩ tự tử với đặc điểm cá nhân (giới tính, áp lực học tập, xu hướng tính dục), các mối quan hệ trong gia đình và trường học [12,13,17]. Mặt khác, nghiên cứu này chúng tôi tìm thấy mối tương quan giữa tình trạng sống chung cùng cha mẹ với ý nghĩ tự tử ở học sinh trong khi nghiên cứu khác lại báo cáo không có mối tương quan giữa 2 yếu tố này [12]. Hầu hết các nghiên cứu đều báo cáo rằng vị thành niên có các trải nghiệm bất lợi và có các vấn đề sức khỏe tâm thần sẽ có khả năng có ý nghĩ tự tử cao hơn [9,12,17]. Một lần nữa, nghiên cứu của chúng tôi khẳng định lại các phát hiện này. Ngoài ra, khi xét tất cả các yếu tố trong nghiên cứu, chúng tôi nhận thấy rằng các vấn đề sức khỏe tâm thần là yếu tố có tác động mạnh mẽ nhất đến ý nghĩ tự tử ở học sinh THPT. Từ kết quả nghiên cứu ghi nhận được đã cho thấy tình trạng sức khỏe tâm thần kém ở học sinh tại TP.HCM đang ở mức đáng báo động. Điều này có thể do ảnh hưởng về mặt tiêu cực của việc thiếu các kỹ năng ứng phó hiệu quả với các nhân tố gây căng thẳng đã trở thành yếu tố góp phần dẫn đến việc mắc các vấn đề sức khỏe tâm thần ở lứa tuổi này [16]. Không những vậy, một nghiên cứu ở Việt Nam đã chứng minh TP.HCM là nơi có vấn nạn sức khỏe tâm thần kém ở lứa tuổi học sinh THPT cao nhất trong 3 thành phố lớn là Hồ Chí Minh, Hà Nội và Huế [18]. Nghiên cứu của chúng tôi đã khẳng định lại kết quả trên với cỡ mẫu lớn hơn gấp 5 lần (1374 so với 268) và chỉ xét riêng học sinh THPT tại TP.HCM nhằm đưa ra một cái nhìn khách quan và tổng quát nhất về tình hình sức khỏe tâm thần ở nhóm đối tượng này.

Mặt khác, mối quan hệ giữa ý nghĩ tự tử và các hành vi nguy hại sức khỏe đã được nhấn mạnh ở nhiều nghiên cứu trước đây [12,14]. Trong nghiên cứu này, phần lớn các hành vi nguy hại sức khỏe đều có mối liên quan với sự hiện diện ý nghĩ tự tử ở vị thành niên, ngoại trừ hành vi hút thuốc lá ($p=0,842$). Hơn nữa, các hành vi nguy hại này thường phối hợp với nhau và gây ảnh hưởng đến ý nghĩ tự tử ở mức độ cao hơn. Kết quả của chúng tôi thể hiện điều tương tự với các nghiên cứu trước rằng khi số lượng hành vi tăng thì khả năng dự báo ý nghĩ tự tử cũng tăng theo, cụ thể đối với học sinh có đồng thời từ 3 hành vi nguy hại trở lên dự báo ý nghĩ tự tử cao gấp 2,91 lần học sinh không có hoặc chỉ có 1 hành vi. Hầu hết các nghiên cứu trước đây, mặc dù có đề cập đến các hành vi lối sống ảnh hưởng đến ý nghĩ tự tử nhưng kết quả đáng quan tâm lại là vấn đề trầm cảm, lo âu. Vì lẽ đó, chúng tôi mong muốn tìm hiểu một cách toàn diện tất cả các

khía cạnh có tác động đến ý nghĩ tự tử, trong đó cần xác định các yếu tố lối sống có thể thay đổi được. Như vậy, ngoài các yếu tố nguy cơ tiềm ẩn đã được biết đến rộng rãi trước nay như sức khỏe tâm thần kém, các trải nghiệm bất lợi trong quá khứ, các vấn đề học tập, môi trường sống, các đặc điểm dịch tễ học thì các hành vi nguy hại sức khỏe cũng cần được quan tâm, chú trọng nhiều hơn bởi mức độ phổ biến và hậu quả tiêu cực không chỉ về sức khỏe lâu dài mà nó còn góp phần gia tăng ý nghĩ tự tử và hành vi tự tử ở độ tuổi vị thành niên đầy thách thức, nhạy cảm và bùng nổ này.

Kết quả nghiên cứu này có một số hạn chế. Đầu tiên, mặc dù cỡ mẫu lớn nhưng thực tế chúng tôi chỉ chọn những học sinh đang đi học tại 4 trường THPT do đó kết quả có thể không thật sự khái quát cho toàn bộ học sinh THPT trên toàn TP.HCM. Thứ hai, nghiên cứu sử dụng bộ câu hỏi tự điền nên có thể có sai lệch trong trả lời. Thứ ba, đây là nghiên cứu cắt ngang, mối liên quan được quan sát trong nghiên cứu này không có ý nghĩa nhân quả và cần phải được xác nhận trong các nghiên cứu dịch tễ khác.

5. KẾT LUẬN

Tỷ lệ học sinh THPT tại TP.HCM có ý nghĩ tự tử và các hành vi nguy hại sức khỏe ở mức cao. Nghiên cứu tìm thấy mối liên quan có ý nghĩa thống kê giữa các hành vi nguy hại sức khỏe, các yếu tố cá nhân, gia đình, môi trường học tập, trải nghiệm bất lợi, sức khỏe tâm thần kém với ý nghĩ tự tử. Kết quả của nghiên cứu có thể giúp nhận diện học sinh có các hành vi và các yếu tố nguy cơ góp phần hình thành ý nghĩ tự tử để từ đây có thể xây dựng các chương trình ngăn ngừa tự tử tập trung vào các đối tượng cụ thể nhằm đạt hiệu quả tối ưu.

Lời cảm ơn

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn Ban giám hiệu các trường THPT và thầy cô đã tạo điều kiện và hỗ trợ trong quá trình thu thập dữ liệu. Nhóm nghiên cứu cũng xin gửi lời cảm ơn đến quý phụ huynh học sinh/người giám hộ và các bạn học sinh đã tham gia nghiên cứu này.

Nguồn tài trợ

Nghiên cứu này được tài trợ kinh phí bởi Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh theo hợp đồng số 147/2024/HĐ-ĐHYD, Ngày 17 tháng 4 năm 2024.

Xung đột lợi ích

Không có xung đột lợi ích tiềm ẩn nào liên quan đến bài viết này được báo cáo.

ORCID

Thái Thanh Trúc

<https://orcid.org/0000-0003-2512-8281>

Đóng góp của các tác giả

Ý tưởng nghiên cứu: Thái Thanh Trúc

Đề cương và phương pháp nghiên cứu: Nguyễn Thị Trang

Thu thập dữ liệu: Trần Thị Hoài Thương, Mai Lê Xuân

Giám sát nghiên cứu: Lê Võ Hồng Tuyết

Nhập dữ liệu: Trần Thị Hoài Thương, Mai Lê Xuân

Quản lý dữ liệu: Lê Võ Hồng Tuyết

Phân tích dữ liệu: Nguyễn Thị Trang, Lê Võ Hồng Tuyết

Viết bản thảo đầu tiên: Nguyễn Thị Trang

Góp ý bản thảo và đồng ý cho đăng bài: Thái Thanh Trúc

Cung cấp dữ liệu và thông tin nghiên cứu

Tác giả liên hệ sẽ cung cấp dữ liệu nếu có yêu cầu từ Ban biên tập.

Chấp thuận của Hội đồng Đạo đức

Nghiên cứu đã được thông qua Hội đồng Đạo đức trong nghiên cứu Y sinh học thuộc Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, số 290/HĐĐĐ-ĐHYD ký ngày 01/02/2024 và số 577/HĐĐĐ-ĐHYD ký ngày 10/04/2024 và sự đồng ý bằng văn bản của 4 trường THPT tham gia nghiên cứu.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. World Health Organization. Suicide. 2023. URL: <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/suicide>.
2. Psychiatry Anomalous Aortic Origin of a Coronary Artery. Suicide in Children and Teens. 2021. URL: https://www.aacap.org/AACAP/Families_and_Youth/Facts_for_Families/FFF-Guide/Teen-Suicide-010.aspx.
3. Cha CB, Franz PJ, M Guzmán E, Glenn CR, Kleiman EM, Nock MK. Annual Research Review: Suicide among youth - epidemiology, (potential) etiology, and treatment. *J Child Psychol Psychiatry*. 2018 Apr;59(4):460-482.
4. Lastrucci V, Lazzeretti M, Innocenti F, Lorini C, Berti A, Silvestri C, et al. Trends in Adolescent Health Risk Behaviors and Wellbeing: A 10 Year Observation from the EDIT Surveillance of Tuscany Region, Italy. *Int J Environ Res Public Health*. 2022 Jun 3;19(11):6863.
5. Smith LM, Wells TT. Suicidal Ideation and Risky Behavior are Related through Impulsivity and Low Wish to Live. *Arch Suicide Res*. 2023 Jul-Sep;27(3):1019-1033.
6. Centers for Disease Control and Prevention. YRBSS Questionnaires. 2023. URL: www.cdc.gov/healthyyouth/data/yrbs/questionnaires.htm.
7. Le MTH, Tran TD, Holton S, Nguyen HT, Wolfe R, Fisher J. Reliability, convergent validity and factor structure of the DASS-21 in a sample of Vietnamese adolescents. *PLoS One*. 2017 Jul 19;12(7):e0180557.
8. Centers for Disease Control and Prevention. 2021 YRBS Data User's Guide. 2021. URL: <https://www.cdc.gov/healthyyouth/data/yrbs/data.htm>.
9. Nguyen Thi Khanh H, Nguyen Thanh L, Pham Quoc T, Pham Viet C, Duong Minh D, Le Thi Kim A. Suicidal behaviors and depression "among adolescents in Hanoi, Vietnam: A multilevel analysis of data from the Youth Risk Behavior Survey 2019. *Health Psychol Open*. 2020 Sep 11;7(2):2055102920954711.
10. Thái Thanh Trúc, Trần Phước Đoàn. Các yếu tố liên quan đến ý nghĩ tự tử ở học sinh trung học phổ thông tại Tây Ninh. *Y học Thành phố Hồ Chí Minh*. 2016, 20(1):163-168.
11. Arnarsson A, Sveinbjornsdottir S, Thorsteinsson EB, Bjarnason T. Suicidal risk and sexual orientation in adolescence: a population-based study in Iceland. *Scand J Public Health*. 2015 Jul;43(5):497-505.
12. Guedria-Tekari A, Missaoui S, Kalai W, Gaddour N, Gaha L. Suicidal ideation and suicide attempts among Tunisian adolescents: prevalence and associated factors. *Pan Afr Med J*. 2019 Oct 22;34:105.
13. Zygo M, Pawłowska B, Potembska E, Dreher P, Kapka-Skrzypczak L. Prevalence and selected risk factors of suicidal ideation, suicidal tendencies and suicide attempts in young people aged 13-19 years. *Ann Agric Environ Med*. 2019 Jun 17;26(2):329-336.
14. Li X, Chi G, Taylor A, Chen ST, Memon AR, Zhang Y, et al. Lifestyle Behaviors and Suicide-Related Behaviors in Adolescents: Cross-Sectional Study Using the 2019 YRBS Data. *Front Public Health*. 2021 Nov 19;9:766972.
15. Le MT, Holton S, Nguyen HT, Wolfe R, Fisher J. Poly-victimisation and health risk behaviours, symptoms of mental health problems and suicidal thoughts and plans among adolescents in Vietnam. *Int J Ment Health Syst*. 2016 Oct 10;10:66.
16. Weiss B, Dang HM, Lam TT, Nguyen MC. Urbanization, and child mental health and life functioning in Vietnam: implications for global health disparities. *Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol*. 2020 Jun;55(6):673-683.
17. Kumar P, Srivastava S, Mishra PS, Sinha D. Suicidal Ideation Among Adolescents-The Role of Sexual Abuse, Depression, and Impulsive Behavior. *Front Psychiatry*. 2021 Dec 20;12:726039. La TT, Dinh HT, Phan MT, Do LT, Nguyen PT, Nguyen QN. Mental health among Vietnamese urban late adolescents: The association of parenting styles. *Health Psychol Open*. 2020 Sep 4;7(2):2055102920948738.